



HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Définition:

- Distension du bassinet et des calices, uni- ou bilatéral, ce qui induit l'atrophie progressive du parenchyme rénal.

Étiologie:

- dans la majorité des cas il existe une anomalie congénitale qui génère un **obstacle mécanique ou fonctionnel** des voies excrétrices mais qui peuvent être des causes héritées;



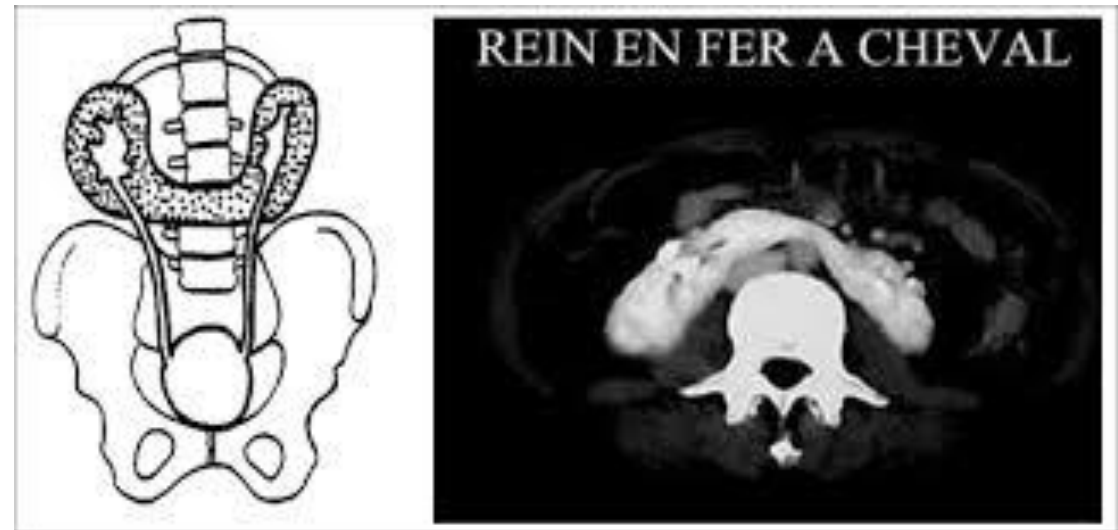
• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Étiologie:

⌘ *Obstacle mécanique:*

a. extrinsèque:

- vaisseaux polaires inférieurs;
- brides fibreuses et adhérentes congénitales péri-pyélo-urétérales;
- insertions hautes de l'uretère;
- reins ectopiques ,
- rein en fer à cheval.





HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Étiologie:

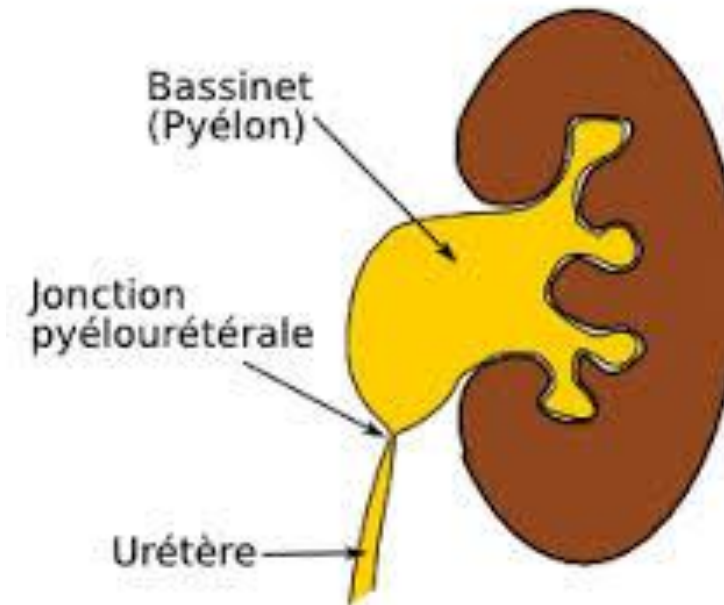
α *Obstacle mécanique:*

b. intrinsèque:

- hypoplasie de la jonction pyélo-urétérale;
- valve ou diaphragme de muqueuse.
- les anomalies de la jonction pyélo-urétérale déterminent 75% des cas d'hydronéphrose

α *Obstacle fonctionnel:*

- dysfonction de la musculature au niveau de la jonction par anomalies neuromusculaires ou maladie d'Hirschsprung





HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Pathogénie:

En présence d'obstacles, la musculature du bassinet s'hypertrophie ce qui force l'évacuation de l'urine;

- la pression intra-caliciale accrue détermine l'affectation de la filtration glomérulaire et du parenchyme rénal;
- apparaît l'atrophie du parenchyme rénal auquel contribuent aussi les infections ajoutées (toujours présentes).

Incidence:

- affection la plus fréquente chez le sexe féminin;
- localisation prépondérante du côté gauche.



• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Symptomatologie:

- douleurs de type colliquatif par rétention bassinétales;
- pyurie - signe le plus fréquent;
- polyurie
- polydipsie;
- troubles gastro-intestinaux (inappétence, vomissements, dyspepsie);
- syndrome fébrile prolongé;
- formation tumorale dans le flanc avec contact lombaire :
- caractère de **tumeur fantôme** ;
- état général influencé;
- anémie;
- déficit staturo-pondéral





• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Diagnostic positif:

- sur la base des **signes cliniques** décrits et examens complémentaires:
- **détermination de la rétention azotée;** (urée créatinine , acide urique)
- **examen d'urine** - albuminurie, hématurie leucocyturie;
- **uro-culture** -identification d'un germe pathogène.
- **urographie i.v.**
- investigation paraclinique d'élection;
- permet l'appréciation du grade de sévérité de l'hydronéphrose:





• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

α Gr. I:

- bassinets globuleux, avec bordure inférieure convexe, sans déformation calicéale, sans affectation du parenchyme rénal.

α Gr. II:

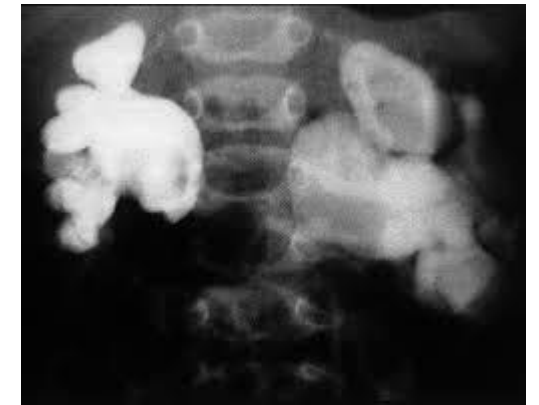
- bassinets dilatés, calice arrondi, papilles effacées, parenchyme réduit.

α Gr. III:

- distension marquée du bassinets et des calices sous forme d'une opacité sphérique, parenchyme très réduit, sécrétion retardée.

α Gr. IV:

- rein non fonctionnel, urographiquement muet





• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Diagnostic positif:

- l'urographie;
- peut établir un **diagnostic prénatal**, chez le nouveau né et chez les enfants avec IR ou rein non fonctionnel;
- ne peut préciser en détail l'étiologie de la maladie et;
- ne peut préciser d'informations sur la fonction rénale





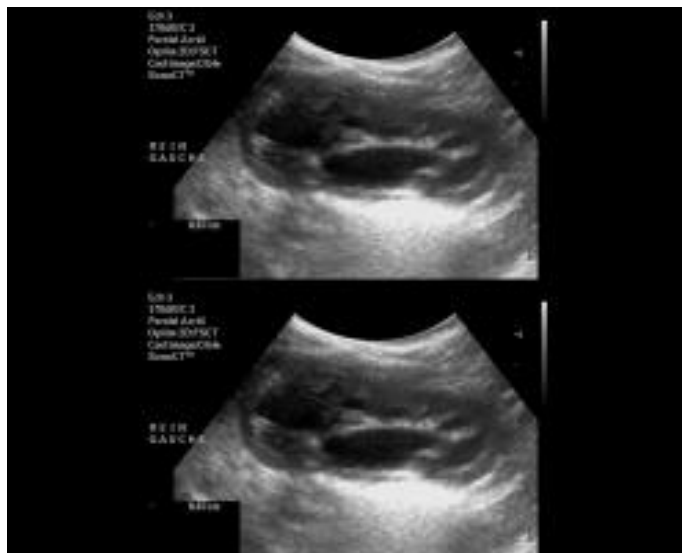
• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Diagnostic positif:

Échographie prenatale:



Échographie postnatale:





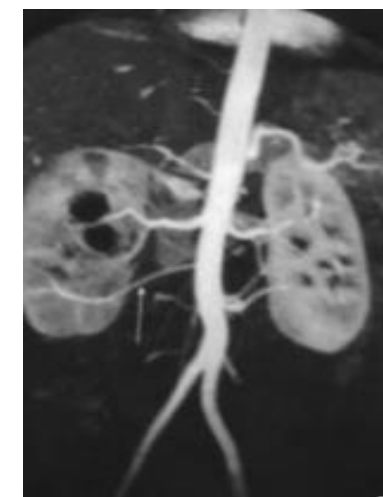
• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Diagnostic positif:

- **cystographie** -
met en évidence
d'éventuelles
anomalies
associées (reflux
vésico-urétéral);



-**artériographie**
rénale sélective -
peut mettre en
évidence les
vaisseaux aberrants

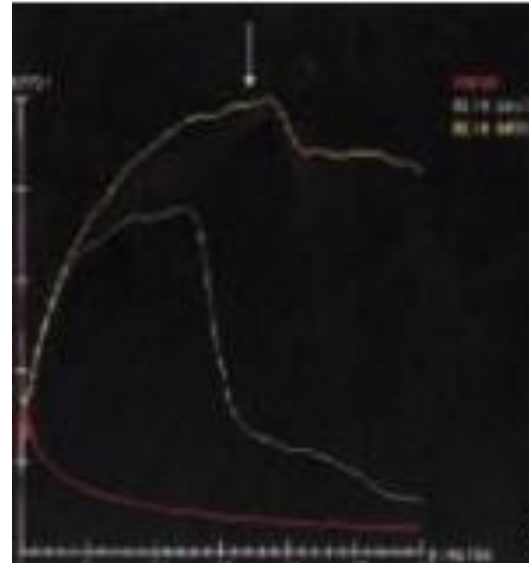




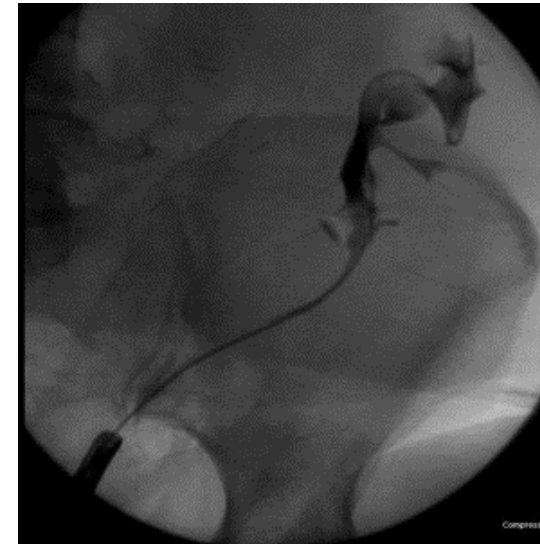
• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Diagnostic positif

- **nephrogramme isotopique** -
apprécie la fonction rénale;



- **pyélographie rétrograde**
ou trans-lombaire
est pratiqué parfois en
préopératoire





• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Diagnostic différentiel:

- Néphroblastome;
- Tumeurs rétro-péritonéales(tératome, neuroblastome) avec compression et dilatation pyélo-calicéale secondaire ;
- Dilatation pyélo-calicéale congénitale (n'existe pas d'obstacle et d'affection du parenchyme rénal);
- Anomalies kystiques rénales.

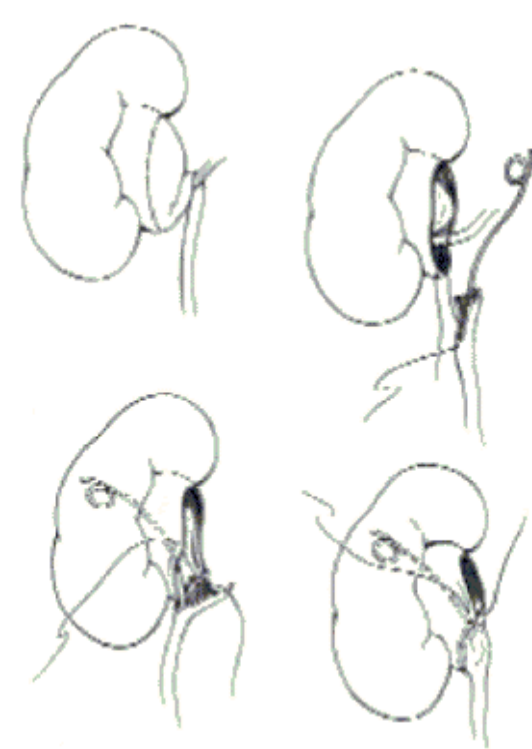




• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Traitement:

- ⌘ **Médical:** - résolution de l'anémie et stérilisation de l'urine.
- ⌘ **Chirurgical:**
 - adapté à la cause:
 - **suppression** des adhérences, brides et coudures avec libération de l'uretère;
 - **décroisement de l'uretère** (vaisseaux polaires inférieurs);
 - **sectionnement des vaisseaux aberrants** si pas importants;



Pieloplastie Aderson Hynes avec presence d'un vaisseau polaire décroise dans le meme temps opératoire



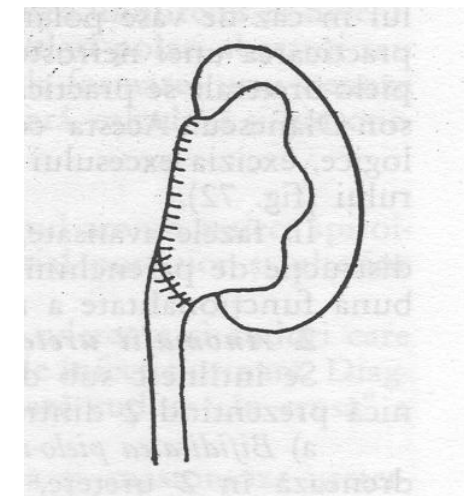
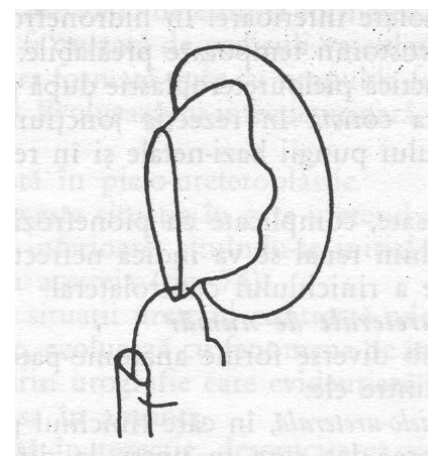
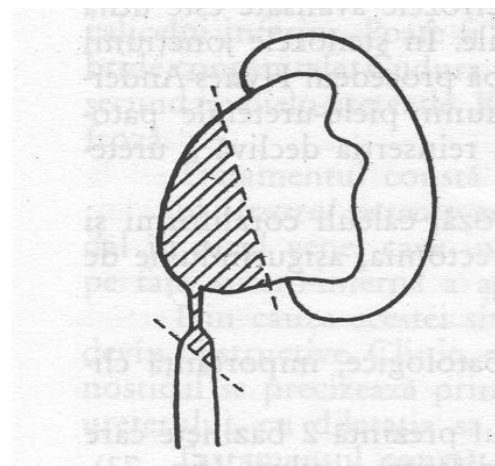
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



• HYDRONÉPHROSE CONGÉNITALE

Traitement chirurgical:

- **pyélo-urétéroplastie (Hynes-Anderson-Olănescu)** dans les sténoses de la jonction pyélo-urétérale;
- **néphrostomie temporaire** - dans les hydronéphroses avancées;
- **néphrectomie** dans l'hydronéphrose de grade IV - après contrôle préalable du rein controlatéral.





REIN POLYKYSTIQUE

Affection décrite par **Virchow** en 1869;

-Fréquence :de 1/1.000-1/4.000 nouveau-nés vivants;

-Anatomo – pathologique:

Augmentation considérable du volume rénal par présence de nombreux kystes au niveau du parenchyme;

Cause d'insuffisance rénale (IR).



REIN POLYKYSTIQUE

Étiologie:

- maladie avec caractère héréditaire,
- déterminée par une altération générale du collagène;
- bilatérale dans 95% des cas;
- affecte aussi d'autres organes:
 - foie, rate,
 - pancréas,
 - gonades,
 - poumons;
- les kystes se doivent à l'obstruction glomérulaire, tubulaire et sur les tubes sécréteurs

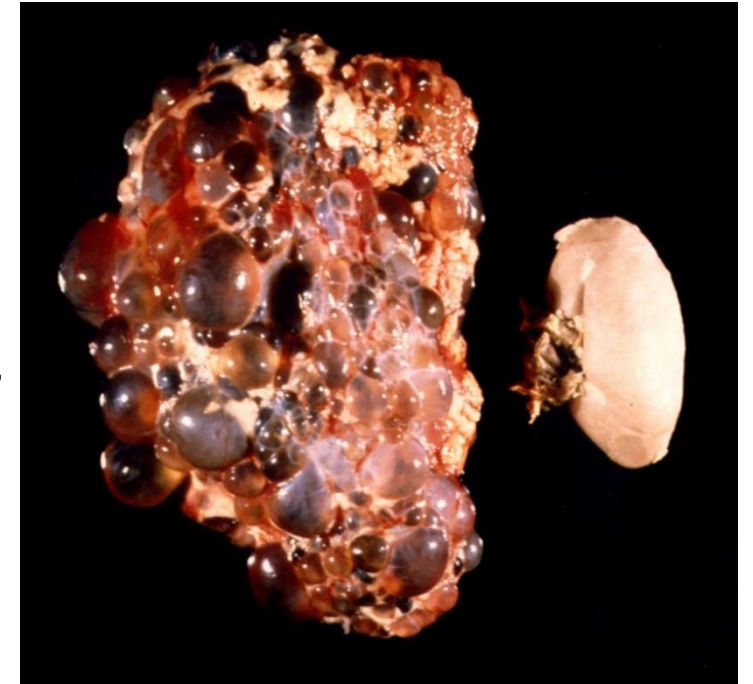




REIN POLYKYSTIQUE

Formes anatomo-cliniques:

- *α Rein polykystique infantile:*
- - forme avec évolution plus sévère;
- - se manifeste immédiatement après la naissance avec:
 - oligurie,
 - augmentation du volume abdominal,
 - hypertension artérielle;
- - l'urée sanguine est élevée,
- - les reins sont accrus de volume, de forme intacte,
- - en section , aspect hexagonal;
- - le décès peut survenir immédiatement après la naissance par insuffisance rénale.





REIN POLYKYSTIQUE

- **Formes anatomo-cliniques:**

- ✗ ***Rein polykystique de type adulte:***

- forme la moins grave, avec début insidieux, rare dans l'enfance;
 - se manifeste **cliniquement** par:
 - des douleurs lombaires et sur les côtés
 - des maux de tête
 - l'hématurie,
 - l'hypertension artérielle,
 - infections urinaires,
 - s'installe progressivement l'insuffisance rénale.

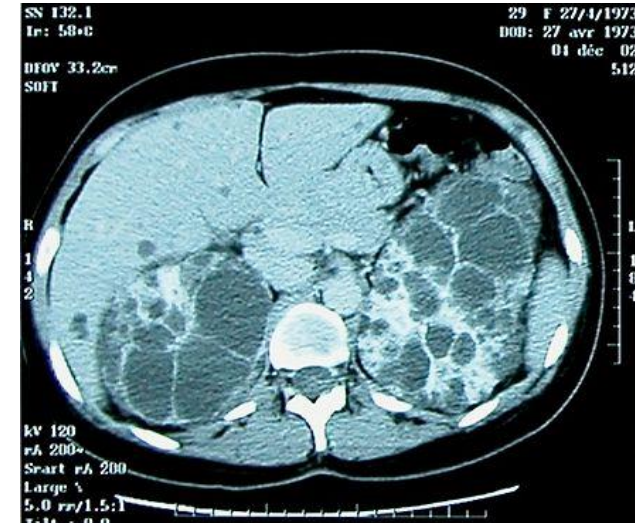




REIN POLYKYSTIQUE

Diagnostic positif:

- sur la base de la symptomatologie clinique décrite;
- biologique - rétention azotée;
- investigations imagistiques:
 - échographie, urographie;
 - contour rénal agrandi,
 - les kystes ne deviennent pas opaques,
- scintigraphie rénale.





REIN POLYKYSTIQUE

Évolution, pronostique:

- évolution grave, menant au décès
- bien qu'il n'existe à ce jour aucun moyen de guérir la maladie ni traitement spécifique, la plupart des personnes peuvent mener une vie normale.

Traitement:

- **Douleur** : pour soulager la douleur causée par les kystes, on peut **drainer** les grands kystes, réduisant ainsi la pression qu'ils exercent sur les tissus avoisinants
- Dans les cas sévères, on pourrait procéder à une **ablation des kystes** par chirurgie
- **L'hypertension artérielle**; prise de certains médicaments
 - **Infections urinaires**; doivent être traitées avec des antibiotiques
 - **L'insuffisance rénale** traitement de dialyse ou la greffe rénale.





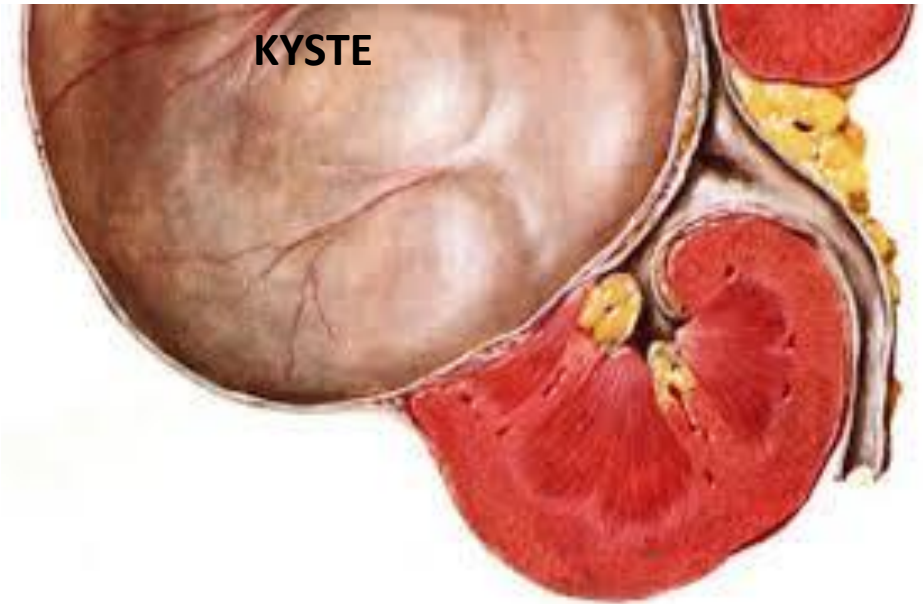
KYSTE RÉNAL SOLITAIRE

Kyste rénal solitaire:

- présence d'une formation kystique, sphérique, avec contenu clair ou hémorragique, de grande dimension, d'habitude au pôle supérieur d'un des reins.

Clinique:

- palpation d'une formation tumorale au contact lombaire;
- épisodes douloureux colliquatifs,
- hématurie;
- HTA;
- syndrome de compression des organes voisins





KYSTE RÉNAL SOLITAIRE

Diagnostic positif:

- **urographie** - image lacunaire dans l'aire rénal (les kyste ne deviennent pas opaques);
- **l'échographie** met en évidence la formation kystique.

Treatment:

- pas obligatoire si asymptomatique;
- **chirurgical** - ablation du kyste ou;
 - néphrectomie polaire

